

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : حنان ابراهيم محمد عدلى

المحافظة : الجيزة

الحى / المدينة : امبابه

العنوان : امبابة

رقم البطاقة : 26903292102541 رقم التليفون : 01022339455

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 29-03-1969 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام رنين مغناطيسي علي الفقرات القطنيه بالصبغه
[12771]

[12771]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالم
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د.ا ----- / د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حنان ابراهيم محمد عدل National ID: 26903292102541	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced MRI of the lumbar spine
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

MDT FORM

4 / 3 / 2026 G

G

<u>Name</u>	حنانہ ارم محمد علی	<u>MRN</u>	6576
		<u>ID</u>	
<u>Age</u>	۵۷	<u>Phone</u>	01022339455
<u>Menopausal status</u>		<u>Marital status</u>	۵79-۳۵۹۵۱-۵۵۸۱
<u>NRS SCORE</u>		<u>Family history</u>	-ve FH
<u>BMI</u>		<u>REASON OF MDT</u>	
<u>CO morbidity</u>	Medically free		

Clinical Data

BX: IDC				R		L	
ER: 8/8	PR: 5/8	HER 2: +1	Ki67: 50%				
Sonomammography: LOQ mass with internal microcalcification 3 → 4 o'clock							
Mets Workup: mass 29 X 21 zone B → C Non specific Axillary LN C.T → Lytic focus in L2				T N M			
Recommendations: Bone scan: Lytic lesion at 8th rib (Traumatic)							
MDT OUTCOME & PLAN				for upfront BCS + SLNB			

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Hikaru Ka	U. P. Singh	Neeraj			



Patient Name : الأستاذ / حنان ابراهيم محمد
Patient No. : 26903292102541
Path No. : 3666/25
Sex : Female
Age : 56 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003614
Request Date : 25/11/2025
Verification Date : 03/12/2025
Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data

Left breast mass.

Nature of specimen

Tru cut biopsy collected on 25/11/2025, at 13:58 , cold ischemia time :0 seconds .

Gross examination

Four grey white tissue cores ranging in size from 0.5 cm up to 1 cm,, totally submitted .

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: HER2/NEU (4B5), KI67 (30-9), PR (1E2), ER (SP1).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (2+2+2) Grade 2
- * DCIS: Absent
- * Lobular intra epithelial neoplasia : Absent
- * Angioinvasion: Absent .
- * Microcalcification :Absent
- * Perineural invasion: Absent
- IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in 98 % tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Strong nuclear reaction in 10 % tumor cells (Allred score 5/8)
- * HER2: Faint incomplete membrane reaction in >10 % of tumor cells (1+)
- * Ki 67: 50 %

Verified by :

Dr.Heba Hasan



Patient Name	: الأستاذ / حنان ابراهيم محمد	Request No.	: 13003614
Patient No.	: 26903292102541	Request Date	: 25/11/2025
Path No.	: 3666/25	Verification Date	: 03/12/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis

LEFT BREAST MASS, TRU CUT BIOPSY

-Invasive duct carcinoma Grade 2 (tubular differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2)
(according to Nottingham grading system of breast cancer) ,

IPT:

* ER: Positive (score 8/8).

* PR: Positive (score 5/8).

* HER2: score +1

* Ki67: 50 %

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature

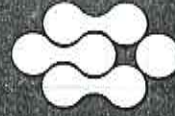
Dr.Walaa Ibrahim Ghoneim

Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :

Dr.Heba Hasan





Patient Name: Hanan ibraheim Mohamed.

Date: Saturday, November 15, 2025

LEFT SONO- MOAMMOGRAPHY

- The breast composition shows average fibroglandular and fatty tissue ACR b.
- two lower outer speculated opacities are seen .
- Normal skin and the subcutaneous tissues lines.
- Normal nipple and retro-areolar region.
- No evidence of mammographic micro-calcifications.
- left mammographic axillary lymphadenopathy.
- Complementary US shows:
 - left lower outer quadrant well defined irregular hypoechoic soft tissue mass lesion with internal vascularity and posterior shadowing measures 2.2 x 2.2 cm seen at 4 o'clock.
 - Other similar lesion with same criteria measures 9 x 10 mm seen at 5 o'clock and the distance from the nipple measures 22 mm and 8 mm from the skin.
 - Simple cyst seen at 10 o'clock BIRADS II.
 - Duct systems are not dilated.
 - left axillary reactive lymphadenopathy with preserved hilum the largest at the left side measures 16 x 7 mm.

Conclusion:

- Left breast tow suspicious lesions as described BIRADS IVb for histopathological correlation.
- Left axillary reactive lymphadenopathy.

WITH MY BEST REGARDS
Dr. ABD ELHAKEAM ATEF.

فرع الوراق :
٢٧ شارع كورنيش النيل - أمام
فرع التوحيد والنور - وراق الحضرة
الوراق.

فرع عزة الصعايدة :
شارع عبد المنعم عسران - عزة
الصعايدة - أعلى مسجد أولاد
عمرو - أمبابة.

فرع امبابة :
شارع نادي امبابة الرياضي - بجوار
مسجد الجمعية الشرعية - أمام
بنك مصر.



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



حنان
ابراهيم محمد عدلى
ش ٢٠ - مدينة التحرير
امبابه - الجيزه

١٩٦٩/٠٣



٢ ٦ ٩ . ٣ ٢ ٩ ٢ ١ . ٢ ٥ ٤ ١

LU2663510

